

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN

UROLOGÍA – ATENCIÓN PRIMARIA

**HOSPITAL REINA SOFIA -
DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR**

Con el objeto de mejorar la comunicación entre la UGC de Urología del Hospital Reina Sofía y las distintas UGCs del Distrito Córdoba y Guadalquivir, se ha establecido un grupo de trabajo con profesionales de los dos ámbitos asistenciales, que además de dar respuesta a las incidencias que se generan en la práctica diaria, garantice la mejora en la calidad asistencial en los pacientes.

Para ello, se establecen unos criterios de derivación por parte de Atención Primaria que permitan la actuación en acto único por parte de Atención Hospitalaria, y a su vez mejoren la comunicación y resolución de incidencias entre ambos niveles asistenciales, evitando que se generen consultas innecesarias y repetición de trámites administrativos ajenos a su práctica asistencial.

Para ello, se establecen los siguientes grupos de patología por motivos de consulta.

1.- DISFUNCIÓN ERECTIL (DE)

Se define como la inhabilidad consistente o recurrente para obtener y/o mantener una erección penéana suficiente para la actividad sexual durante al menos 3 meses.

La valoración y manejo inicial de la disfunción eréctil, en varones correspondería a Atención Primaria. Se recomienda una adecuada anamnesis para identificar posibles causas secundarias de DE, sobre todo factores de riesgo cardiovascular y fármacos (fundamentalmente betabloqueantes y diurético tiazídicos).

Pruebas complementarias.

- Se solicitará analítica general con perfil lipídico y glucémico, y que incluya PSA (según proceso HBP) y TESTOSTERONA Total.

Criterios de derivación:

- Si existe alteración analítica en los parámetros de PSA o testosterona solicitados (la alteración en el PSA y testosterona se debería confirmar en una segunda determinación).
- Contraindicación para el tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE5)
- Falta de respuesta al tratamiento inicial con IPDE5 o pérdida de eficacia.

Inicio de tratamiento: Puede iniciarse tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE 5) salvo contraindicación:

- Enfermedad cardíaca en los siguientes casos:
 - o Tratamiento simultaneo con NITRATOS. Totalmente contraindicado.
 - o Angina INESTABLE.
 - o Insuficiencia cardíaca grave.
- Insuficiencia hepática grave.
- Retinitis pigmentaria.

En caso de ser eficaz, se dará por resuelta la consulta manteniendo el tratamiento de forma indefinida.

	Sildenafil (Viagra®)	Vardenafil (Levitra®)	Tadalafil (Cialis ®)	Avanafil (Spedra ®)
Dosis*	25,50 y 100 mg	5,10 y 20 mg	5,10 y 20 mg	50,100 y 200 mg
Tiempo mínimo inicio actividad sexual tras la toma (minutos)	60 min	30-60 min	60 min	30-60 min
Duración efecto	5-12 horas	8-12 horas	36 horas	5-17 horas
Relación con la ingesta	Si (2 horas de ayuno previas)	NO	NO	NO
Efectos adversos específicos	Alt. visuales Dispepsia. Mareos.	Dispepsia. Mareos.	Mialgias. Dolor espalda. Dispepsia	Dolor espalda.
Efectos adversos comunes a todos	Asociados a los efectos vasodilatadores (cefalea, rubor facial, palpitaciones, congestión nasal ...)			
* Se recomienda iniciar la dosis mas alta para comprobar su eficacia. Posteriormente se puede reducir, en general a la mitad, permaneciendo con esta dosis si es efectiva.				
** Existe una presentación de tadalafil que puede utilizarse de manera diaria a dosis de 5mg.				

Si tras la valoración por Urología procede revisión, está será gestionada por el propio servicio de Urología. En caso de ser alta, así se hará constar de forma inequívoca.

2.- CÓLICO NEFRÍTICO. UROLITIASIS

El cólico nefrítico es un episodio de dolor de alta intensidad, tipo espasmo, con grandes picos de dolor y acompañado en general de síntomas vegetativos que suele reflejarse en zona inguinal, no relacionados con los movimientos y cambios posturales. Normalmente son autolimitados en el tiempo y con buena respuesta al tratamiento con AINEs y analgésicos, aunque en la mayoría de las ocasiones suelen ser atendidos en los servicios de urgencias.

El cólico nefrítico aislado, con o sin expulsión visible de litiasis y que ha respondido de forma satisfactoria al tratamiento **no precisa valoración por urología**. En estos casos se entregarán las recomendaciones elaboradas por el servicio de Urología. En caso necesario, podrá solicitarse radiología de abdomen y sedimento de orina como parte del diagnóstico.

Deberán remitirse a Urología, siempre **con radiología simple de abdomen incluyendo pelvis completa y sedimento de orina**:

- Cuadros compatibles con cólico nefrítico, que aun resolviéndose de forma rápida, se repiten en el tiempo (3 episodio en 1 mes).
- Cuadros compatibles con cólico nefrítico, sin resolución completa del dolor en el plazo de 2-4 semanas, aunque este no sea de alta intensidad sin expulsión del cálculo

En el caso de hallazgo incidental de litiasis en vía urinaria en la realización de cualquier prueba solicitada por ese u otro motivo se contactará mediante correo electrónico con el urólogo de referencia para determinar la forma de proceder.

Los casos de cólico nefrítico de alta intensidad y resistente al tratamiento analgésico convencional, deberá ser valorado en el servicio de urgencias para descartar complicaciones.

3.- PATOLOGÍA PROSTÁTICA NO INFECCIOSA

o ELEVACIÓN DE PSA

Las derivaciones a Urología por PSA elevado deben realizarse **siempre con una confirmación del resultado a partir de 4 semanas tras la primera determinación** y evitar así falsos positivos. La información deberá ir asociada a un cuestionario IPSS y un sedimento de orina.

Es importante que no exista un proceso agudo (sospecha de infección urinaria por clínica o sedimento de orina). Si es así deberá tratarse antes de repetir un nuevo PSA.

Las elevaciones confirmadas de PSA serán remitidas al urólogo para su valoración. Tras ser valorados, y en el caso de que se proceda al alta, se indicarán de forma clara la actitud a seguir por parte de Atención Primaria, ya sea con la realización o no de PSA de forma sistematizada, así como los valores o incrementos que puedan producirse para una nueva valoración.

Aunque todos los valores elevados de PSA deben ser valorados por urología, en caso de duda sobre el manejo de un valor de PSA, podrá contactarse con el urólogo de referencia para marcar la actitud a seguir.

o HBP (Hipertrofia Benigna de Próstata)

Tradicionalmente la HBP se ha considerado como un síndrome clínico que se caracteriza por un crecimiento prostático que se acompaña de una serie de síntomas que se conocen como Síntomas de Tracto Urinario Inferior (STUI).

STUI de Llenado	STUI de Vaciado	STUI Postmiccionales
Urgencia	Chorro débil	Sensación de vaciado incompleto
Nicturia	Micción en regadera	
Frecuencia	Chorro intermitente	Goteo postmiccional
Incontinencia	Retardo miccional	
	Esfuerzo miccional	
	Goteo terminal	

Desde atención primaria, los cuadros compatibles con HBP deberán ser evaluados mediante la realización de IPSS y determinación de PSA, procediendo de la siguiente forma:

- Si elevación de PSA: Tras su confirmación en una segunda determinación, se remitirá para valoración por urología tal y como se describe en el apartado anterior.

- Con IPSS leve (puntuación entre 0-7 puntos): Las formas leves no precisan iniciar tratamiento de forma habitual, por lo que en aquellos pacientes que presenten mala tolerancia a los síntomas, se reforzarán las medidas higiénicas y/o iniciando tratamiento (alfabloqueante).
- Con IPSS moderados (entre 8-19) o graves (entre 20-35): Se iniciará tratamiento desde Atención Primaria con alfabloqueante. La aparición de efectos secundarios que no permitan la toma del fármaco o la no mejoría clínica manifestada por el paciente será criterio de derivación a Urología.

En caso de precisar derivación, además de una anamnesis completa que incluya tipo de sintomatología y duración, se hará referencia a los valores de IPSS y el tratamiento empleado (asociado a PSA y sedimento de orina que ya tendrá solicitado de inicio).

En el caso de que tras la valoración inicial el paciente precise revisiones, estas serán gestionadas directamente por el propio servicio. Si por el contrario fuese alta, se reflejará en el informe de manera inequívoca. En caso de pacientes de alta por STUI/HBP en los que aparezca nueva sintomatología, elevación de PSA no conocida o falta de respuesta al tratamiento ya iniciado, se contactará con el urólogo de referencia para plantear el manejo de este paciente.

o CÁNCER DE PRÓSTATA

En pacientes con Cáncer de próstata tratados con prostatectomía radical, tras el seguimiento por urología durante los años establecidos en el proceso, se procederá al alta, para seguimiento anual de valores de PSA por parte de Atención Primaria.

Se indicará en el informe de alta la periodicidad y nuevos valores de referencia del PSA, para su seguimiento por Atención Primaria.

La elevación de valores de PSA sobre el valor de partida indicado de derivación o de consulta con urólogo de referencia en aquellos casos en los que surjan dudas.

4.- INFECCIONES DE ORINA EN LA MUJER (CISTITIS)

La cistitis suele manifestarse como disuria, polaquiuria, urgencia miccional, cambios en la coloración y olor de forma aguda... bien de forma aislada o en combinación de ellos.

- **Cistitis aguda:** se realizará tratamiento antibiótico empírico de pauta corta sin necesidad de urocultivo. En aquellas **cistitis relacionadas con las relaciones sexuales y/o con la menstruación**, tanto con cultivo positivo o no, pueden tratarse con antibiótico en dosis única tras la relación sexual o al inicio de la menstruación.

El manejo de los episodios aislados en mujeres sin **factores de riesgo*** se hará desde atención primaria, incluyendo además del uso de antibiótico, la entrega de recomendaciones elaboradas por el servicio de urología.

- **Cistitis de repetición:** Se habla de cistitis de repetición la presencia de más de 2 episodios comprobados en 6 meses o 3 en al año.

En estos cuadros se debe solicitar urocultivo previo a comenzar el tratamiento antibiótico, y posteriormente tratar con pauta larga de una semana según antibiograma.

Criterios de derivación:

- Cuadros repetidos de clínica sugestiva de cistitis con urocultivos negativos.
- Cistitis que no mejoran a pesar de recomendaciones previas.

En todos los casos, además del resultado de los cultivos realizados, **se realizará analítica general con función renal y sedimento urinario que acompañará a la derivación.**

***Se consideran factores de riesgo de ITU complicada:** Sexo masculino, niños, embarazo, clínica de más de 7 días, alteraciones urológicas anatómicas o funcionales, diabetes mal controlada, manipulaciones urinarias, ITU recientes por gérmenes resistentes, inmunodeficiencias.

Cualquier otra situación o duda sobre el manejo en un proceso concreto, se gestionará con el urólogo de referencia a través del correo electrónico.

5.- PROSTATITIS AGUDA

La prostatitis aguda es una inflamación de la próstata producida por una infección bacteriana.

Los factores de riesgo para el desarrollo de prostatitis son manipulaciones urológicas, alteraciones anatómicas genitourinarias (HBP, fimosis ...) y antecedentes de infecciones urinarias previas (cistitis, uretritis ...).

La clínica de prostatitis suele consistir en:

- STUI: Disuria, polaquiuria, urgencia miccional ...
- Dolor genitourinario: Perineal, lumbosacro, anal, eyaculatorio ...
- Síntomas generales: Fiebre elevada y afectación importante del estado general.

El manejo inicial de la prostatitis se realizará en atención primaria con la instauración de un tratamiento antibiótico de amplio espectro durante 4-6 semanas y con la realización de un cultivo de orina y/o semen con objetivo de identificar el germen y ajustar mejor el tratamiento antibiótico. Se puede asociar al tratamiento antibiótico el uso de alfabloqueantes y AINEs para el manejo sintomático.

La no respuesta al tratamiento iniciado en 48-72 horas, así como la aparición de retención urinaria y o síntomas sistémicos sugestivos de gravedad (hipotensión + taquicardia, afectación conciencia ...) **serán remitidos a urgencias.**

La no resolución completa del cuadro por síntomas persistentes sin fiebre (aun siendo de baja intensidad) así como la aparición de un segundo episodio **será criterio de derivación a urología**, que deberá ir acompañado de una determinación analítica general con función renal, sedimento de orina y PSA.

EN RESUMEN:

El objetivo de estos acuerdos es facilitar la consulta en acto único por parte del servicio de urología, mejorando su capacidad de resolución y accesibilidad a otros pacientes del SSPA.

Para ello, se establece que:

- 1.- Toda derivación a urología deberá realizarse con unos mínimos criterios de calidad en los que de forma inexcusable se informe del tiempo de evolución y el tratamiento empleado cuando proceda. La no inclusión de esta información en la derivación podrá ser motivo de devolución por falta de información.
- 2.- Toda sospecha de patología subsidiaria de ser valorada por urología o duda diagnóstica, será remitida para su valoración con los criterios antes mencionados. Tras la valoración, el servicio de urología emitirá en todos los casos un informe a través de Diraya, dónde de forma inequívoca conste si se procede al alta o si procede revisión, en cuyo caso, será gestionada directamente por el servicio.
- 3.- Para los pacientes que tras su valoración se indique un tratamiento o recomendaciones para el paciente, todas las prescripciones necesarias se realizarán a través de la aplicación de RXXI, y en caso de precisar revisión, con fecha de validez hasta la siguiente revisión.
- 4.- Los pacientes que ya han sido valorados por un motivo de consulta concreto con informe de alta por parte del servicio de urología y en dónde su médico de familia entienda que la evolución no es satisfactoria, se contactará con el urólogo de referencia por medios telemáticos, y en caso de consensuar una nueva valoración, esta se generará como revisión a través de la UAC.
- 5.- Si tras una consulta con urología, el urólogo determina que procede otra consulta con cualquier otro servicio hospitalario, esta se hará a través de Interconsulta Hospitalaria y no a través de Atención Primaria.
- 6.- El servicio de urología garantizará la comunicación telemática con los centros de atención primaria, nombrando referentes en cada uno de los centros y dando respuesta a las dudas y consultas solicitadas en el plazo establecido.
- 7.- El grupo de trabajo entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria mantendrá reuniones periódicas para valorar en cumplimiento de estos acuerdos.